CENTRE HOSPITALIER FICTIF DES COTEAUX
Pôle d'addictologie - CSAPA - 3, allée des Fictifs - 33210 LANGON
Tél. 05 00 21 43 65 Finess 33 0 99981 2

BROUSTAUT THIERRY Admission A1905140017
Né le 14/03/1973 (53 ans)
IPP 0093318472 UF 5130 - Addictologie
18 chemin du Pradas, 33490 SAINT-MACAIRE

HISTORIQUE DES OBSERVATIONS

Entretien téléphonique du 07/05/2019 (Urgence : Bas)

Validé par GARROS Fabienne - IDE le 07/05/2019 à 11:20
Appel de M. BROUSTAUT Thierry, 46 ans, qui demande un RDV "pour l'alcool". Il explique d'emblée que c'est "une obligation" : permis annulé en mars par le tribunal, obligation de soins à justifier auprès du SPIP. Dit aussi que sa femme lui a "posé un ultimatum".
Pas de signe de sevrage décrit au téléphone mais reconnait boire "tous les jours, pas mal". Chef d'équipe dans le bâtiment, toujours en poste, se fait conduire au travail par un collègue.
RDV médical donné le 14/05 à 9h avec le Dr LOUSTAUNAU. Rappelé l'intérêt de venir à jeun pour le bilan. Tél : 06 47 83 15 92.

Observation médicale d'entrée du 14/05/2019 (Urgence : Bas)

Validé par LOUSTAUNAU Agnès - Psychiatre addictologue le 14/05/2019 à 12:48
Observations :
Première consultation. M. BROUSTAUT, 46 ans, chef d'équipe maçon, marié, deux enfants, adressé par lui-même dans le cadre d'une obligation de soins (annulation du permis de conduire pour conduite sous l'emprise de l'alcool), "et aussi parce que ma femme en a marre". Vient accompagné de son épouse, Mme Sylvie BROUSTAUT, qui reste en salle d'attente à sa demande.

Motif : demande d'aide pour arrêter l'alcool, ambivalente au départ ("je suis là parce que le juge l'a dit"), plus personnelle au fil de l'entretien ("de toute façon je ne tiens plus, je tremble le matin").

Histoire de la consommation d'alcool :
- Premier verre vers 14 ans, "au mariage d'un cousin", puis ivresses du samedi soir avec les copains vers 15-16 ans (bière, vin, panaché).
- Usage régulier au service militaire (19 ans, Mont-de-Marsan) : "là-bas on buvait tous les soirs", puis à l'entrée dans l'entreprise de maçonnerie au retour, bière sur le chantier à midi et le soir, "c'était la culture".
- Perte de contrôle qu'il situe "vers la trentaine" : impossibilité de s'arrêter une fois commencé, premières consommations le matin, augmentation progressive.
- Consommation actuelle : 6 à 8 bières de 50 cl (8°) par jour et 3 à 4 pastis le soir, soit environ 12 à 15 UIA/j, premier verre vers 7h "pour arrêter de trembler", plus le week-end. Ne boit pas "devant les gars" depuis qu'il est chef d'équipe : bières dans le camion.
- Maximum : "plus de 20 verres" certains samedis.
- Sevrages antérieurs : un sevrage "à la maison" avec son médecin traitant (Dr PEYRÉ) en 2014, "tenu trois semaines" ; un sevrage hospitalier dans notre unité en 2016 (premier et seul sevrage hospitalier selon lui), suivi d'une abstinence "d'un an à peu près", puis reprise progressive en 2017 "pour un repas de chantier". Pas de cure ni de postcure.
- Pas d'antécédent de crise convulsive ni de délirium tremens rapporté. Tremblements matinaux, sueurs, nausées au réveil, soulagés par la bière.

Autres produits :
- Tabac depuis l'âge de 13 ans, actuellement 25 cigarettes par jour, jamais de tentative d'arrêt. Fagerström 8.
- Cannabis : quelques joints vers 18 ans, rien depuis.
- Nie toute autre substance ("jamais touché à la drogue, la coke c'est pas mon monde").
- Pas de médicament détourné, pas de benzodiazépine.
- Jeux d'argent : grattage "de temps en temps", pas de difficulté rapportée.

Antécédents psychiatriques : une "déprime" en 2016 après le sevrage, traitée par paroxétine par le médecin traitant pendant "un an environ", arrêtée seul. Pas d'hospitalisation en psychiatrie. Pas d'antécédent de tentative de suicide (question posée directement, répond "non" sans hésiter). Pas de suivi psychiatrique antérieur. Sommeil : endormissement "grâce à l'alcool", réveils vers 4h avec sueurs. Pas d'élément psychotique, pas d'élément maniaque. Anxiété surtout matinale, qu'il relie au manque.

Antécédents somatiques : HTA non traitée ? (TA élevée chez le MT, pas de traitement). Lombalgies chroniques "du

métier". Pas d'hépatopathie connue, "jamais fait d'écho". Appendicectomie dans l'enfance. Pas de traumatisme crânien rapporté. Pas d'allergie connue. Vaccinations "à jour pour le tétanos, avec le métier". Sérologies VHB/VHC/VIH jamais faites, pas de facteur de risque déclaré.

Antécédents familiaux : père (Roger, 71 ans, ancien maçon) "buveur, mais pas méchant", toujours consommateur, suivi pour le foie. Mère en bonne santé. Un frère, Didier, "qui boit un peu aussi". Pas d'antécédent psychiatrique familial connu. Grand-père paternel "mort du foie" selon lui.

Biographie : né en 1973 à Toulenne, deuxième de deux garçons. Enfance décrite "sans particularité, à la campagne". Scolarité jusqu'en 3e, puis apprentissage à 16 ans, CAP de maçon. Service militaire à 19 ans. Entré dans la même entreprise de maçonnerie de Langon au retour de l'armée, chef d'équipe depuis une dizaine d'années, "le patron compte sur moi". Marié depuis 1999 avec Sylvie (aide à domicile), deux enfants : Kevin, 18 ans, en apprentissage de plombier, et Manon, 13 ans, au collège. Propriétaires d'une maison à Toulenne, crédit en cours. Justice : contrôle routier "en novembre 2018", alcoolémie à 1,6 g/L, suspension puis annulation du permis par jugement en mars 2019 avec obligation de soins. Pas d'autre antécédent judiciaire. Le couple "va mal depuis un moment" : sa femme menace de partir s'il ne se soigne pas. Loisirs : pêche, football le dimanche (dirigeant bénévole d'un club jusqu'en 2017, "arrêté à cause de la buvette"). Journée type : lever 5h30, "deux bières pour démarrer", chantier, bières dans le camion à 10h et à midi, retour vers 18h, pastis à la maison, coucher vers 22h "assommé".

Examen : patient corpulent, visage érythrosique, haleine œnolique à 9h. Tremblements fins des extrémités, sueurs. TA 158/97, FC 98. Éthylotest 0,62 g/L. Pas de confusion, orienté. Pas de signe de décompensation hépatique à l'examen. Discours cohérent, un peu minimisant. Thymie : fatigue, irritabilité, sommeil "à l'alcool", pas d'élément dépressif franc à ce jour, pas d'idées suicidaires.

Critères DSM-5 : 9/11 (perte de contrôle, désir persistant, temps consacré, craving, échec des obligations, poursuite malgré les problèmes relationnels, situations dangereuses avec la conduite, tolérance, sevrage). Trouble de l'usage de l'alcool sévère. Trouble de l'usage du tabac sévère.

Conclusions :
TUAL sévère avec dépendance physique, échecs de sevrages antérieurs. Patient en obligation de soins mais demande personnelle qui se dessine. Pas d'antécédent suicidaire déclaré.
- Sevrage résidentiel dans notre unité, inscription sur liste d'attente (délai 4 à 6 semaines).
- Bilan : NFS, VGM, GGT, ASAT/ALAT, CDT, TP, lipase, ionogramme. Échographie abdominale pendant le séjour.
- Thiamine 250 mg/j dès maintenant.
- Pas de baisse brutale d'ici le sevrage (risque), réduction progressive proposée.
- Suivi IDE avec Mme GARROS, rencontre avec l'assistante sociale (situation professionnelle, permis).
- Attestation de suivi remise pour le SPIP.
RDV dans 3 semaines.

Observation IDE du 21/05/2019 (Urgence : Bas)

Validé par GARROS Fabienne - IDE le 21/05/2019 à 16:05
M. BROUSTAUT vu pour bilan et premier entretien infirmier. Bilan prélevé ce matin à jeun (enfin "à jeun d'alcool depuis 6h", précise-t-il en souriant).
AUDIT 31. Fagerström 8. Éthylotest 0,38 g/L à 8h30.
Il dit avoir réduit "d'une ou deux bières" depuis la consultation. Pas de tremblements ce matin.
Explication du déroulement du sevrage dans l'unité (durée 10 à 12 jours, pas de téléphone les 3 premiers jours, visites possibles). Il s'inquiète surtout pour le travail : "si je m'arrête deux semaines, le patron va comprendre". Conseillé d'en parler avec l'AS.
Résultats à récupérer la semaine prochaine.

Observation sociale du 28/05/2019 (Urgence : Bas)

Validé par DUVIGNAC Sandrine - Assistante sociale le 29/05/2019 à 09:40

HISTORIQUE DES OBSERVATIONS

Premier entretien social.
Situation : M. BROUSTAUT Thierry, né le 14/03/1973, marié, 2 enfants dont 1 mineure (Manon, 13 ans). Domicile : 7 impasse des Gravettes, 33210 TOULENNE (maison, crédit immobilier jusqu'en 2031).
Emploi : CDI, chef d'équipe dans une entreprise de maçonnerie de Langon (depuis 1993). Salaire environ 2 100 € net. Épouse aide à domicile à temps partiel.
Permis : contrôle routier le 22/12/2018 (alcoolémie 1,6 g/L), suspension administrative, puis jugement du tribunal correctionnel le 19/03/2019 : annulation du permis, interdiction de le repasser pendant 6 mois, obligation de soins 18 mois. Suivi SPIP en cours.
Trajets : covoiturage avec un collègue, "le patron arrange les plannings".
Difficultés : crédit voiture + crédit immobilier, découvert "de temps en temps". Pas de dettes déclarées à ce jour.
Démarches : information sur l'arrêt maladie pendant le sevrage (pas d'obligation de donner le motif à l'employeur), attestations de suivi pour le SPIP, information sur la commission médicale du permis pour plus tard.
RDV à la sortie du sevrage.

Observation médicale d'entrée du 17/06/2019 (Urgence : Bas)

Validé par BERNADET Hugo - Interne le 17/06/2019 à 17:32
Observations :
Entrée programmée en unité de sevrage pour un sevrage d'alcool, patient suivi au CSAPA par le Dr LOUSTAUNAU.
Rappel : TUAL sévère, début des consommations à 15 ans, quotidiennes depuis le service militaire, perte de contrôle vers 30 ans. Conso actuelle 12-15 UIA/j (bière forte + pastis). Sevrages : ambulatoire 2014, hospitalier 2016 dans l'unité (1er sevrage hospitalier), abstinence 1 an. Tabac 1,5 paquet/j. Pas de crise convulsive, pas de DT. Permis annulé début 2019 (alcool au volant), obligation de soins. Épisode dépressif en 2016 traité par paroxétine. Pas de TS.
Dernière consommation ce matin à 6h30 (2 bières).
Examen : TA 162/98, FC 104, T 37,2. Sueurs, tremblements des extrémités, anxiété. Cushman 8. Pas de confusion. Éthylotest 0,41 g/L à l'arrivée.
Bilan du 21/05 : GGT 412, VGM 102, ASAT 89, ALAT 61, TP 88 %, plaquettes 168 G/L, CDT 5,4 %, lipase normale.
Conclusions :
Sevrage par oxazépam (ASAT élevées, foie à explorer) selon protocole Cushman : 50 mg x 4 à J1. Thiamine 500 mg/j IV 3 jours puis per os. Hydratation. Surveillance Cushman toutes les 4h. Échographie abdominale demandée.

Observation infirmière du 18/06/2019 (Urgence : Bas)

Validé automatiquement le 19/06/2019 à 06:00 par LATAPIE Jean-Marc
Nuit difficile. Pt reveille a 0h30, sueurs ++, tremblements, angoisse, "j'ai des fourmis partout". Cushman 10 a 1h -> oxazepam 50mg supp selon protocole. Cushman 6 a 3h. TA 160/95.
Pas d'hallucination, oriente. A fume sur le balcon a 4h (signale).
Endormi vers 4h30.

Observation médicale de suivi du 21/06/2019 (Urgence : Bas)

Validé par BERNADET Hugo - Interne le 21/06/2019 à 14:10
Observations :
J4 du sevrage. Nuits plus calmes depuis le 19/06. Cushman 3. Oxazépam en décroissance (150 mg/j).
Échographie abdominale : foie augmenté de volume, stéatose diffuse, pas de dysmorphie, pas d'ascite, pas de lésion focale. Pancréas normal.
Patient plus détendu, participe au groupe de parole de l'après-midi. Dit "cette fois c'est la bonne, pour ma femme et pour la petite".
Conclusions :
Poursuite de la décroissance de l'oxazépam. Introduction de l'acamprosate à discuter avec le Dr LOUSTAUNAU. Patchs nicotiniques proposés, refusés ("une chose à la fois").

Observation médicale de sortie du 28/06/2019 (Urgence : Bas)

Validé par LOUSTAUNAU Agnès - Psychiatre addictologue le 28/06/2019 à 11:55
Observations :

HISTORIQUE DES OBSERVATIONS

Sortie ce jour après 12 jours de sevrage. Pas de complication (pas de convulsion, pas de confusion). Oxazépam arrêté le 26/06. Cushman 0.
A participé aux groupes de parole et à l'atelier d'éducation thérapeutique ("l'alcool et le foie"). Visite de son épouse et de Manon le week-end, "ça s'est bien passé, elle m'a trouvé mieux". Il appréhende surtout le retour sur le chantier et le regard des collègues : préparation de ce qu'il dira ("j'étais malade, je me suis soigné"), boissons sans alcool dans le camion.
TA 132/84. Bilan de sortie : GGT 248 en baisse.
Stéatose hépatique à l'échographie. Craving modéré, surtout à l'idée de reprendre le chantier.
Conclusions :
TUAL sévère, sevrage effectué.
Traitement de sortie : acamprosate 333 mg 2-2-2, thiamine 250 mg/j.
Arrêt de travail jusqu'au 07/07, reprise le 08/07.
Suivi CSAPA : IDE tous les 15 jours, consultation le 16/07 avec l'interne, AS.
Courrier au Dr PEYRÉ.

Observation psychiatrique de suivi du 16/07/2019 (Urgence : Bas)

Validé par BERNADET Hugo - Interne le 16/07/2019 à 18:22
Observations :
Vu ce jour
Reprise du travail le 08/07 comme prévu. Dit ne pas avoir bu depuis la sortie. "Le plus dur c'est midi, quand les gars sortent les bières". Mange dans le camion seul.
Acamprosate bien toléré (selles un peu molles). Dort mieux.
Tabac inchangé, 25 cig/j.
Éthylotest 0,00.
Conclusions :
RO acamprosate 2-2-2, thiamine
Stratégies pour la pause de midi (boissons sans alcool, s'éloigner)
RDV Dr LOUSTAUNAU en septembre

RDV non honoré du 03/09/2019 (Urgence : Bas)

Validé par GARROS Fabienne - IDE le 03/09/2019 à 17:00
Pt non venu au RDV IDE de 14h. Appel à 16h : répondeur. Message laissé.
Rappelle à 16h50 : "j'avais un chantier à Bazas, le collègue ne pouvait pas me ramener à temps". Dit que tout va bien.
RDV redonné le 10/09.

Observation psychiatrique de suivi du 17/09/2019 (Urgence : Bas)

Validé par LOUSTAUNAU Agnès - Psychiatre addictologue le 17/09/2019 à 12:15
Observations :
Abstinent depuis la sortie du sevrage (fin juin), soit près de 3 mois. GGT 64 (412 en mai), VGM 96.
Craving rare, "surtout le vendredi soir". Ambiance meilleure à la maison, a refait la terrasse avec son fils.
Tabac 25 cig/j, pas prêt.
Thymie stable, sommeil correct.
Conclusions :
TUAL en début de rémission.
RO acamprosate 333 mg 2-2-2. Arrêt de la thiamine.
RDV 2 mois, IDE mensuel.

Observation IDE du 22/10/2019 (Urgence : Bas)

Validé par GARROS Fabienne - IDE le 22/10/2019 à 15:40
M. BROUSTAUT arrive en béquilles, botte de marche à gauche. Accident du travail le 15/10 : chute d'un échafaudage (environ 2,50 m) sur un chantier à Saint-Macaire, fracture du calcanéum gauche, vu aux urgences de Langon, traitement orthopédique, pas d'opération pour l'instant. Arrêt de travail AT jusqu'à fin novembre "au moins".

Il insiste : "j'étais à jeun, hein, je n'avais rien bu", le chef de chantier peut en témoigner. Éthylotest 0,00 aujourd'hui.
Inquiet de rester à la maison à rien faire. Ne prend que le paracétamol prescrit.
Vu avec le Dr LOUSTAUNAU : RDV maintenu en novembre, appel IDE dans 15 jours.

Observation psychiatrique de suivi du 26/11/2019 (Urgence : Bas)

Validé par LOUSTAUNAU Agnès - Psychiatre addictologue le 26/11/2019 à 10:30
Observations :
Vu ce jour
En arrêt AT depuis le 15/10 (fracture du calcanéum G), arrêt prolongé jusqu'en janvier, rééducation à venir. S'ennuie, "je tourne en rond". Tensions avec son épouse : elle lui reproche d'être "toujours dans les pattes", il parle de disputes presque tous les soirs. Abstinence maintenue selon lui, craving en hausse l'après-midi.
Pas de tristesse franche, irritabilité.
Conclusions :
RO acamprosate
Proposition d'entretiens de couple refusée par l'épouse (par téléphone)
RDV début janvier, IDE dans 15 jours

Renouvellement du 10/12/2019 (Urgence : Bas)

Validé par GARROS Fabienne - IDE le 10/12/2019 à 09:15
Passage du patient pour renouvellement de l'ordonnance d'acamprosate (ordonnance du Dr LOUSTAUNAU, 3 mois). Pas d'entretien souhaité aujourd'hui, "pressé, ma femme m'attend dans la voiture". Éthylotest refusé poliment.

Observation IDE du 07/01/2020 (Urgence : Bas)

Validé par GARROS Fabienne - IDE le 07/01/2020 à 17:45
M. BROUSTAUT appelle ce matin puis vient sans RDV à 15h. Haleine oenolique, éthylotest 0,86 g/L.
A rebu "depuis le réveillon", d'abord "un verre de champagne pour faire comme tout le monde" chez sa belle-soeur, puis tous les jours : 8 à 10 bières + pastis le soir. Tremblements le matin depuis 3-4 jours.
Sa femme lui a demandé de partir le 3 janvier, il dort chez son frère Didier à Langon. "Elle a raison, je suis un poids".
Pleure pendant l'entretien. Pas d'idée suicidaire exprimée, dit penser à ses enfants.
A arrêté l'acamprosate "à Noël, puisque je buvais".
Vu avec le Dr LOUSTAUNAU qui le voit jeudi. Conseillé de ne pas arrêter brutalement seul. Numéro du service donné pour le week-end.

Observation psychiatrique de suivi du 09/01/2020 (Urgence : Bas)

Validé par LOUSTAUNAU Agnès - Psychiatre addictologue le 09/01/2020 à 13:20
Observations :
Vu ce jour
Rechute depuis le 24/12/2019, après 6 mois d'abstinence. 10 à 12 UIA/j, consommation matinale reprise, signes de sevrage au réveil. Arrêt de l'acamprosate fin décembre.
Contexte : séparation, Mme BROUSTAUT lui a demandé de quitter le domicile le 03/01, hébergé chez son frère. Toujours en arrêt AT (calcanéum), rééducation commencée.
Thymie : tristesse réactionnelle, honte, sentiment d'échec, sommeil mauvais. Pas d'idées suicidaires. Pas de critère d'épisode dépressif caractérisé à ce jour.
Rappel : TUAL sévère, sevrage hospitalier en 2016 puis en juin 2019 dans l'unité, pas de convulsion. Épisode dépressif en 2016.
Conclusions :
Rechute du TUAL sévère avec dépendance physique.
Ne souhaite pas de nouvelle hospitalisation pour l'instant ("je viens de sortir, je vais pas y retourner").
Objectif discuté : réduction d'abord, puis sevrage. Traitement anticraving à revoir à la prochaine consultation (baclofène envisagé).
Thiamine 250 mg/j reprise. IDE hebdomadaire.
RDV avec l'interne début février.

HISTORIQUE DES OBSERVATIONS

Observation psychiatrique de suivi du 04/02/2020 (Urgence : Bas)

Validé par CAZAUBON Inès - Interne le 04/02/2020 à 18:05

Observations :
Patient vu ce jour, seul. A emménagé le 01/02 dans un T2 à Langon (résidence Les Tilleuls), "c'est petit mais c'est chez moi". Voit Manon le mercredi après-midi pour l'instant, en attendant le juge.
Conso actuelle : 8 à 10 bières/j, plus de pastis ("j'ai arrêté les alcools forts"). Tremblements matinaux persistants. Craving +++, "dès que j'ouvre l'oeil".
Toujours en arrêt de travail (AT), marche sans botte depuis mi-janvier.
TA 150/92. Éthylotest 0,24 g/L à 17h.
Accepte un traitement par baclofène après information (somnolence, vertiges, pas de conduite... "ça tombe bien, j'ai plus le permis").
Conclusions :
- Introduction baclofène 5 mg x 3/j, augmentation de 5 mg tous les 3 jours, objectif 60 mg/j puis réévaluation
- Thiamine poursuivie
- Objectif de réduction, carnet de consommation remis
- RDV 1 mois, IDE hebdo

Observation sociale du 03/03/2020 (Urgence : Bas)

Validé par DUVIGNAC Sandrine - Assistante sociale le 03/03/2020 à 11:30

Entretien à la demande de M. BROUSTAUT.
Séparation depuis début janvier 2020, nouvelle adresse depuis le 01/02/2020 : résidence Les Tilleuls, appt 12, 33210 LANGON (loyer 520 €, APL demandée).
Enfants : Manon (13 ans) vit chez sa mère, Kevin (18 ans) aussi, en apprentissage. Mme BROUSTAUT a saisi le juge aux affaires familiales, audience prévue au printemps. M. BROUSTAUT souhaite "au moins un week-end sur deux".
Information sur l'aide juridictionnelle (dossier rempli ce jour).
Il dit s'en vouloir "d'avoir tout cassé", mais tient à payer "sa part" pour les enfants. Il ne sait pas faire les démarches en ligne : accompagnement pour la demande d'APL, création d'un compte CAF ce jour. Mobilier prêté par son frère. Pas de dette déclarée hors crédits en cours.
Arrêt AT depuis le 15/10/2019, indemnités journalières versées normalement. Crédit immobilier toujours payé à deux pour l'instant.
Permis : peut repasser le permis depuis septembre 2019 (fin de l'interdiction de 6 mois), mais doit passer la commission médicale : "pas tant que je bois".
RDV dans 1 mois.

Entretien téléphonique du 07/04/2020 (Urgence : Bas)

Validé par CAZAUBON Inès - Interne le 07/04/2020 à 10:40

Consultation téléphonique (confinement).
Seul dans son appartement depuis le début du confinement, ne voit plus personne, Manon "par vidéo". Consommation en hausse : "une caisse de bières tous les deux jours" + vin, soit environ 15 UIA/j. Sort uniquement pour les courses (alcool compris).
Baclofène pris à 60 mg/j (20-20-20) depuis mi-mars, somnolence l'après-midi, efficacité "pas terrible".
Thymie basse, dort mal, "je ne sers à rien". Pas d'idées suicidaires actives à l'interrogatoire.
Conclusions :
- Poursuite baclofène 60 mg, réévaluation par le Dr LOUSTAUNAU dans un mois
- Appels IDE hebdomadaires pendant le confinement
- Numéro de garde donné

Entretien téléphonique du 12/05/2020 (Urgence : Bas)

Validé par LOUSTAUNAU Agnès - Psychiatre addictologue le 12/05/2020 à 14:55

Observations :
Téléconsultation.
Depuis environ un mois : tristesse quasi permanente, anhédonie ("plus rien ne me fait envie, même la pêche"), insomnie

de fin de nuit, perte d'appétit, fatigue, ralentissement, culpabilité massive vis-à-vis de ses enfants. Idées noires passives ("ce serait plus simple pour tout le monde si je n'étais plus là"), sans projet ni scénario. Les éléments persistent les jours où il dit boire moins.
Consommation un peu réduite depuis 15 jours : 6 à 8 UIA/j, plus de consommation le matin d'après lui.
Conclusions :
Épisode dépressif caractérisé d'intensité moyenne (2e épisode connu après 2016). TUAL sévère, réduction en cours.
- Escitalopram 10 mg/j
- Baclofène augmenté à 90 mg/j (30-30-30) par paliers de 10 mg
- Orientation vers la psychologue du CSAPA (Mme ESQUERRÉ) dès la fin du confinement
- 3114 et numéro du service donnés. Rappel IDE dans une semaine

Observation psychologue du 09/06/2020 (Urgence : Bas)

Validé par ESQUERRÉ Nathalie - Psychologue le 09/06/2020 à 17:20
Premier entretien.
M. Broustaut arrive en avance, masque mal ajusté, parle d'abord du chantier, des collègues, de sa cheville "qui ne sera plus jamais comme avant". Il faut un moment avant qu'il évoque la séparation : "c'est moi qui l'ai cassée, cette famille". L'alcool est décrit comme "le seul truc qui m'éteint la tête". Il raconte son premier verre "à 12 ans, mon père me faisait goûter son vin à table, il trouvait ça drôle". Le père est décrit en quelques mots ("un dur, un taiseux, qui buvait comme tout le monde au village"), puis le sujet est vite refermé.
Beaucoup de honte, une image de lui-même très dévalorisée, une grande difficulté à mettre des mots sur les émotions ("je sais pas, ça va pas, c'est tout").
Il accepte de revenir, "si ça sert à quelque chose".
Éléments de bilan à l'issue de ce premier entretien : homme de 47 ans au fonctionnement longtemps tenu par le travail et le rôle de "chef", qui s'effondre quand ce cadre disparaît (arrêt de travail, séparation, confinement). Alexithymie marquée, tendance à agir plutôt qu'à penser, forte loyauté envers un père dont il parle peu. L'alcool semble avoir une fonction d'anesthésie et de lien (le chantier, les copains, le père). Pas d'élément de personnalité pathologique franc à ce stade.
Demande ambivalente mais réelle, portée par le lien avec sa fille.
Proposition : entretiens tous les 15 jours, travail d'abord sur l'identification des émotions et des situations à risque.

Observation psychiatrique de suivi du 23/06/2020 (Urgence : Bas)

Validé par LOUSTAUNAU Agnès - Psychiatre addictologue le 23/06/2020 à 12:10
Observations :
Vu ce jour, premier RDV en présentiel depuis mars.
Jugement du JAF le 16/06 : résidence de Manon chez sa mère, droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances. "C'est ce que je voulais". Kevin reste chez sa mère mais passe le voir.
Consommation : 4 à 6 bières/j, pas le matin, "jamais devant Manon".
Escitalopram 10 mg depuis 6 semaines : sommeil un peu meilleur, moins de pleurs. Baclofène 90 mg bien toléré.
A commencé avec Mme ESQUERRÉ.
Conclusions :
EDC en amélioration partielle. TUAL sévère, réduction partielle.
RO escitalopram 10 mg, baclofène 90 mg, thiamine
RDV septembre (vacances), IDE toutes les 2 semaines

Appel pharmacie du 21/07/2020 (Urgence : Bas)

Validé par GARROS Fabienne - IDE le 21/07/2020 à 10:05
Appel de la pharmacie de Langon : ordonnance de baclofène arrivée à échéance, le patient demande une avance de 3 jours. Accord du Dr LOUSTAUNAU, nouvelle ordonnance faxée. RAS par ailleurs selon le pharmacien.

Observation psychiatrique de suivi du 15/09/2020 (Urgence : Bas)

Validé par LOUSTAUNAU Agnès - Psychiatre addictologue le 15/09/2020 à 11:40
Observations :
Vu ce jour

HISTORIQUE DES OBSERVATIONS

Bon été avec Manon (15 jours de vacances au camping de Lacanau). Thymie meilleure mais "encore des coups de mou", réveils précoces.
Alcool : dit boire 2 à 3 bières par jour, jamais le matin, "je gère". Demande explicitement de ne pas viser l'abstinence : "je veux boire comme tout le monde". Après discussion, objectif de consommation contrôlée accepté à titre d'essai : 3 UIA/j maximum, 2 jours sans alcool par semaine, carnet de consommation, bilan biologique régulier. Prévenu du risque.
Toujours en arrêt de travail, consolidation de la fracture repoussée, douleurs à la marche.
Conclusions :
TUAL sévère, objectif de réduction (consommation contrôlée) à évaluer à 3 mois.
- Escitalopram augmenté à 15 mg
- Baclofène 90 mg poursuivi
- Bilan bio (GGT, CDT, VGM) + Fibroscan demandé (ASAT/ALAT toujours élevées)
- RDV 2 mois

RDV non honoré du 13/10/2020 (Urgence : Bas)

Validé par GARROS Fabienne - IDE le 13/10/2020 à 16:30
Pt absent au RDV IDE de 15h, sans prévenir. Rappelé : "j'aidais un copain à refaire sa toiture, j'ai oublié". Je lui rappelle l'arrêt de travail et la cheville... Il rit. RDV redonné le 27/10.

Observation psychologue du 17/11/2020 (Urgence : Bas)

Validé par ESQUERRÉ Nathalie - Psychologue le 17/11/2020 à 18:40
Séance importante.
En parlant de l'hiver qui arrive, M. Broustaut dit avoir "peur de refaire comme en 2009". Je lui demande ce qui s'est passé en 2009. Long silence, puis il raconte : une année très noire, dettes après l'achat de la maison, Sylvie qui parlait déjà de partir, il ne dormait plus, "pendant des mois je me levais juste pour aller au chantier". Un soir de septembre 2009, il a avalé "toute la boîte de Doliprane" avec du whisky, dans le garage. C'est sa femme qui l'a trouvé et a appelé les pompiers ; une nuit aux urgences de Langon, "lavage", sorti le lendemain sans suivi. "On n'en a jamais reparlé, ni elle ni moi".
Il ne l'avait dit à personne au CSAPA : "à la première consultation, la docteure m'a demandé, j'ai dit non, j'avais honte, et puis c'était pour le permis". Il accepte que j'en parle au Dr LOUSTAUNAU.
Actuellement : pas d'idées suicidaires, mais une "fatigue de tout". Il dit avoir pensé à cette nuit-là pendant le premier confinement, "seul dans l'appartement, avec les bières", sans aller plus loin.
Il est très soulagé à la fin de la séance : "ça fait onze ans que je le porte". Nous évoquons ensemble ce qui pourrait l'aider à demander de l'aide si les idées revenaient (sa fille, son frère, le numéro du CSAPA).
Poursuite des entretiens tous les 15 jours.

Observation psychiatrique de suivi du 24/11/2020 (Urgence : Bas)

Validé par LOUSTAUNAU Agnès - Psychiatre addictologue le 24/11/2020 à 11:50
Observations :
Vu ce jour
Reprise avec le patient (avec son accord) de ce qu'il a confié à Mme ESQUERRÉ : tentative de suicide en septembre 2009 (IMV paracétamol + alcool, une nuit aux urgences, pas de suivi), dans un contexte d'épisode dépressif non traité. Il n'en avait pas parlé à l'entrée. Je corrige donc les antécédents : 1 TS (2009), 3 épisodes dépressifs (2009, 2016, 2020).
Évaluation du risque : pas d'idées suicidaires actuelles, pas de projet, facteurs de protection (Manon, Kevin, suivi). Plan de crise rédigé avec lui. Le paracétamol est rangé chez son frère.
Fibroscan du 10/11/2020 : 13,2 kPa, compatible avec une fibrose sévère (F3). Bilan du 03/11 : GGT 288, CDT 3,9 %, VGM 99. Il maintient "3-4 bières par jour, pas plus".
Conclusions :
Hépatopathie alcoolique avec fibrose F3 : RDV hépatologie (CH) demandé, échographie tous les 6 mois. Explications données sur le foie, il semble touché.
Consommation contrôlée : résultats biologiques peu compatibles avec ce qu'il déclare, discuté avec lui.
RO escitalopram 15 mg, baclofène 90 mg
RDV 6 semaines

HISTORIQUE DES OBSERVATIONS

Observation IDE du 05/01/2021 (Urgence : Bas)

Validé par GARROS Fabienne - IDE le 05/01/2021 à 16:20
Entretien IDE + résultats du bilan du 29/12 : GGT 341, CDT 4,9 %, VGM 101. Je lui montre les chiffres, il baisse la tête et finit par reconnaître : "plutôt 6 à 8 bières, et plus le week-end quand je n'ai pas la petite". Noël sans les enfants (chez leur mère cette année), "le pire Noël de ma vie".
Pas de consommation matinale "pour l'instant". Pas de tremblements ce jour.
Fume toujours 25 cig/j.
Transmis au Dr LOUSTAUNAU. Il demande lui-même "qu'on arrête de faire semblant avec les 3 verres".

Observation psychiatrique de suivi du 02/02/2021 (Urgence : Bas)

Validé par SARRAZY Clara - Interne le 02/02/2021 à 17:15
Observations :
Patient vu ce jour avec le Dr LOUSTANAU.
Rappel : TUAL sévère depuis la trentaine, sevrages hospitaliers 2016 et 06/2019, rechute 12/2019. EDC (2016, 2020), TS par IMV en 2010 (révélée récemment). Hépatopathie F3.
Depuis début janvier : 10 UIA/j, tremblements matinaux et sueurs, premier verre à 7h, a "lâché le carnet". Reconnaît que la consommation contrôlée "ne marche pas pour moi".
Thymie stable sous escitalopram 15 mg, sommeil médiocre. Pas d'idées suicidaires.
Demande un nouveau sevrage hospitalier, puis une postcure "pour de bon cette fois".
Conclusions :
- Arrêt de l'objectif de consommation contrôlée, objectif d'abstinence
- Inscription sur liste d'attente de l'unité de sevrage (délai environ 2 mois), demande de SSR addictologique à faire après
- Ne pas arrêter brutalement seul (risque de sevrage compliqué) : expliqué deux fois
- RO baclofène 90 mg, escitalopram 15 mg, thiamine

Observation sociale du 09/03/2021 (Urgence : Bas)

Validé par DUVIGNAC Sandrine - Assistante sociale le 09/03/2021 à 10:50
Point de situation.
Arrêt AT depuis le 15/10/2019. Il arrive avec une pochette pleine de courriers non ouverts, que nous trions ensemble.
Visite de pré-reprise le 24/02 avec le médecin du travail : séquelles du calcanéum (douleurs, appui prolongé et travail en hauteur impossibles), inaptitude au poste de chef d'équipe maçon "très probable". L'employeur n'a pas de poste adapté (petite entreprise). M. BROUSTAUT très inquiet : "le bâtiment c'est tout ce que je sais faire".
Finances : la maison de Toulenne est en vente (accord avec Mme BROUSTAUT), crédit voiture, deux crédits renouvelables pris en 2020 ("pour tenir"), loyer, pension alimentaire de 200 €. Retards de paiement depuis décembre.
Procédure de divorce engagée par son épouse.
Démarches : information sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH, dossier MDPH à constituer), information sur le dossier de surendettement (à revoir après la vente de la maison).
RDV dans 1 mois.

Entretien téléphonique du 01/04/2021 (Urgence : Bas)

Validé par GARROS Fabienne - IDE le 01/04/2021 à 09:35
Appel du patient. Raconte qu'il a voulu "s'arrêter tout seul" en fin de semaine dernière pour arriver "propre" au sevrage, et qu'il a fait une "crise" dimanche : son frère l'a trouvé par terre, il s'était mordu la langue, pompiers, urgences de Langon, sorti le soir même avec du Seresta. Il a repris un peu de bière depuis "pour ne pas refaire une crise".
Vu avec le Dr LOUSTAUNAU : entrée en sevrage avancée, l'unité le prend mardi 06/04. Consignes : ne pas arrêter seul, poursuivre une consommation stable jusqu'à l'entrée, oxazépam selon l'ordonnance des urgences, pas de conduite (de toute façon pas de permis).

Observation médicale d'entrée du 06/04/2021 (Urgence : Bas)

Validé par SARRAZY Clara - Interne le 06/04/2021 à 16:58
Observations :
Entrée programmée (avancée) en unité de sevrage pour un sevrage d'alcool, chez un patient de 48 ans suivi au CSAPA

par le Dr LOUSTAUNAU.
Rappel des antécédents :
- TUAL sévère : premières consommations à l'adolescence, usage quotidien depuis le service militaire, perte de contrôle vers 30 ans. Sevrage ambulatoire en 2014 (MT), premier sevrage hospitalier en 2016 dans l'unité (abstinence d'environ un an), sevrage hospitalier en juin 2019 (abstinence de 6 mois), rechute en décembre 2019. Tentative de consommation contrôlée de septembre 2020 à janvier 2021, échec.
- Crise convulsive généralisée fin mars 2021 lors d'un arrêt brutal à domicile (urgences de Langon). Premier épisode.
- Tabac 25 cig/j.
- EDC récurrents (2009, 2016, 2020), TS par IMV en 2009. Sous escitalopram 15 mg.
- Hépatopathie alcoolique, fibrose F3 au Fibroscan de novembre 2020. Stéatose à l'écho de 2019.
- Fracture du calcanéum G (AT, 10/2019), en arrêt depuis.
Traitement à l'entrée : baclofène 90 mg/j, escitalopram 15 mg, thiamine 250 mg, oxazépam 10 mg x 3 depuis les urgences.
Consommation : 8 à 10 bières/j depuis la crise, dernière prise ce matin à 7h.
Examen : TA 155/94, FC 102, sueurs, tremblements, Cushman 9. Morsure latérale de langue en voie de cicatrisation. Pas de confusion, pas d'hallucination. Éthylotest 0,22 g/L.
Contexte : séparé, vit seul à Langon, deux enfants. Licenciement pour inaptitude envisagé. Son frère Didier l'a hébergé depuis la crise et l'a conduit ce matin.
Motivation : "je ne veux plus jamais me réveiller par terre". Demande une postcure à la suite, accord de principe du Dr LOUSTAUNAU.
Conclusions :
Sevrage à haut risque (antécédent de crise convulsive récente, hépatopathie) : oxazépam selon protocole Cushman renforcé, 50 mg x 4 à J1 ; thiamine 500 mg x 2 IV ; surveillance rapprochée. Baclofène diminué à 60 mg/j pendant le sevrage. Avis neurologique non nécessaire en l'absence d'autre crise (EEG à discuter si récidive). Bilan biologique complet. Fibroscan de contrôle pendant le séjour. Demande de SSR addictologique à envoyer.

Observation infirmière du 07/04/2021 (Urgence : Bas)

Validé automatiquement le 08/04/2021 à 06:00 par LATAPIE Jean-Marc
Nuit agitee jusqu'a 2h. Cushman 11 a 23h -> oxazepam 50 supp. Cushman 7 a 2h. Pas de crise, pas de myoclonie. TA 158/99. Tremblements ++, sueurs. Hydrate (1,5 L).
Pt dit "j'ai peur de refaire une crise comme dimanche". Rassure.
Dort de 2h30 a 5h30.

Observation médicale de suivi du 13/04/2021 (Urgence : Bas)

Validé par SARRAZY Clara - Interne le 13/04/2021 à 15:30
Observations :
J8. Sevrage sans nouvelle crise, Cushman 1 depuis 3 jours. Oxazépam en décroissance, arrêt prévu en fin de semaine.
Fibroscan de contrôle fait cette semaine : élasticité stable, F3. Bilan : GGT 318, plaquettes 141 G/L, TP 79 %, albumine normale.
Accord de principe du SSR addictologique de Cadillac (Clinique du Tourne) pour une entrée le 10/05.
Patient demandeur, "cette fois je fais tout le programme".
Conclusions :
Poursuite décroissance oxazépam, arrêt prévu le 16/04.
Introduction acamprosate 333 mg 2-2-2 avant la sortie.
Sortie prévue en début de semaine prochaine, entre-temps hébergement chez son frère.

Observation psychiatrique de suivi du 04/05/2021 (Urgence : Bas)

Validé par LOUSTAUNAU Agnès - Psychiatre addictologue le 04/05/2021 à 10:20
Observations :
Vu ce jour, sorti mi-avril de l'unité de sevrage, abstinent depuis.
Reçu ce jour le compte rendu d'hospitalisation de l'unité (Dr LABAT). En reprenant le dossier d'archives de l'hôpital, l'unité y signale un sevrage hospitalier plus ancien, en mars 2011, à la Clinique des Iris (Lormont), dont le compte rendu avait été

adressé au médecin traitant à l'époque. Le patient, interrogé, confirme : "c'était une semaine, je suis parti avant la fin, pour moi ça ne comptait pas". Le premier sevrage hospitalier date donc de 2011 et non de 2016 comme noté à l'entrée.
Le CR mentionne "pas d'antécédent de geste suicidaire" : erreur, la TS de 2009 est connue chez nous depuis novembre 2020 (non transmise à l'unité). Courrier de correction adressé au Dr LABAT.
Craving modéré. Thymie : "je me sens plus solide qu'en 2019". Sommeil correct.
Conclusions :
- Entrée en SSR addictologique (Clinique du Tourne, Cadillac) le 10/05/2021, 5 semaines
- Acamprosate 333 mg 2-2-2
- Escitalopram augmenté à 20 mg
- Baclofène 60 mg : décroissance de 10 mg par semaine jusqu'à l'arrêt, à poursuivre en SSR
- Thiamine
- RDV à la sortie du SSR

Observation sociale du 15/06/2021 (Urgence : Bas)

Validé par DUVIGNAC Sandrine - Assistante sociale le 15/06/2021 à 14:05
Entretien après la sortie de SSR.
Licenciement pour inaptitude notifié par courrier le 08/06/2021, pendant son séjour en SSR. Indemnité de licenciement en cours de calcul. Inscription à Pôle emploi faite. Dossier MDPH (RQTH) déposé en mai.
En faisant le point sur les amendes en attente, M. BROUSTAUT me montre une convocation au tribunal de police pour le 06/07/2021 : il avait été contrôlé en février 2020 au volant de sa voiture, sans permis. Il reconnaît avoir conduit sans permis "plusieurs mois en 2019, pour aller sur les chantiers quand le collègue ne pouvait pas", puis début 2020 "pour aller voir Manon". Il n'en avait parlé à personne ("j'avais peur que ça remonte au juge pour l'obligation de soins"). Conseil : se présenter à l'audience, aide juridictionnelle demandée.
Maison de Toulenne vendue en mai, une partie de la vente a soldé le crédit immobilier.
RDV en septembre.

Observation psychiatrique de suivi du 22/06/2021 (Urgence : Bas)

Validé par LOUSTAUNAU Agnès - Psychiatre addictologue le 22/06/2021 à 12:40
Observations :
Vu ce jour
Sorti du SSR addictologique le 11/06/2021 après 5 semaines, programme complet. Très positif sur les groupes ("pour la première fois, je n'étais pas le seul"). Programme : groupes de parole quotidiens, ateliers de prévention de la rechute, activité physique adaptée (marche, piscine malgré la cheville), entretiens individuels avec le médecin et la psychologue de la clinique, une séance avec son fils Kevin. Deux permissions de week-end sans consommation, une passée avec Manon.
Il ramène un "plan de prévention de la rechute" écrit à la main, qu'il me montre : situations à risque (le vendredi soir, les repas de famille, la solitude, les papiers), personnes à appeler (son frère, Mme GARROS), ce qu'il fera à la place de boire.
Abstinent depuis fin mars, soit près de 3 mois. Baclofène arrêté en SSR fin mai.
Licenciement pour inaptitude le 08/06, vécu "comme une claque, même si je le savais".
Thymie correcte, pas d'idées suicidaires. Sommeil bon.
Conclusions :
TUAL sévère en début de rémission. EDC en rémission.
- RO acamprosate 333 mg 2-2-2, escitalopram 20 mg, thiamine
- Groupe de prévention de la rechute du CSAPA (jeudi) proposé, accepté
- RDV 2 mois, psychologue tous les 15 jours

Observation psychologue du 07/09/2021 (Urgence : Bas)

Validé par ESQUERRÉ Nathalie - Psychologue le 07/09/2021 à 18:10
Reprise après l'été. M. Broustaut parle de son père, qu'il est allé voir à l'hôpital (problèmes de foie). En sortant de la chambre, il dit avoir eu "envie de lui crier dessus, et en même temps de le serrer".
Puis, pour la première fois, il décrit son enfance autrement que "sans histoire" : le père rentrait ivre presque tous les soirs, frappait sa mère, et le frappait lui "à la ceinture, pour un rien, une assiette pas finie". Cela a duré "de mes 8 ans jusqu'à ce que je parte en apprentissage, à 15-16 ans". Il pense que son frère aîné a été moins touché "parce qu'il était déjà parti".

HISTORIQUE DES OBSERVATIONS

"Je me suis juré de ne jamais devenir comme lui. Et je bois comme lui." Pleure longuement.
Il n'en avait jamais parlé, même à Sylvie. Ne souhaite pas que ce soit "écrit partout", accepte que le Dr LOUSTAUNAU soit informé.
Travail à venir sur la honte, la colère, la transmission. Séances hebdomadaires pendant un mois.

Observation psychiatrique de suivi du 12/10/2021 (Urgence : Bas)

Validé par LOUSTAUNAU Agnès - Psychiatre addictologue le 12/10/2021 à 11:05
Observations :
Vu ce jour
Abstinent depuis fin mars (6 mois et demi). GGT 96, VGM 94, CDT normale.
Informée par Mme ESQUERRÉ (avec son accord) des violences paternelles subies dans l'enfance, jamais évoquées jusque-là ("enfance sans particularité" à l'entrée).
Anxiété importante depuis le licenciement (argent, avenir). Le Dr PEYRÉ lui a prescrit du bromazépam 6 mg (½-½-1) "depuis septembre". Prévenu des risques (dépendance, association à l'alcool), il dit en prendre "rarement plus d'un le soir".
Hépatologie (consultation du 05/10) : fibrose F3, pas de signe d'hypertension portale, échographie semestrielle.
Thymie correcte.
Conclusions :
- RO acamprosate, escitalopram 20 mg
- Courrier au Dr PEYRÉ : limiter le bromazépam, durée courte, prescripteur unique
- RDV 2 mois

Observation sociale du 23/11/2021 (Urgence : Bas)

Validé par DUVIGNAC Sandrine - Assistante sociale le 23/11/2021 à 15:20
Divorce prononcé le 05/10/2021 (divorce par consentement mutuel). Garde de Manon inchangée.
Audience du 06/07/2021 pour conduite sans permis : amende de 800 €, échelonnée.
Dettes : deux crédits renouvelables, retards de loyer (2 mois), amende. Ressources : ARE environ 1 300 €. Pension alimentaire maintenue.
Dossier de surendettement constitué avec M. BROUSTAUT et déposé à la Banque de France le 18/11/2021.
RQTH accordée.
RDV janvier.

RDV non honoré du 18/01/2022 (Urgence : Bas)

Validé par GARROS Fabienne - IDE le 18/01/2022 à 16:00
Pt absent au RDV IDE. Rappelle de lui-même à 17h, s'excuse : "j'étais à la Banque de France à Bordeaux, dossier recevable". Va bien, dit-il, "toujours rien bu". RDV le 01/02.

Observation éducative du 08/03/2022 (Urgence : Bas)

Validé par BENSALAH Karim - Éducateur spécialisé le 08/03/2022 à 17:00
Première rencontre, orientation par le Dr LOUSTAUNAU pour travailler le projet professionnel et l'occupation des journées.
Thierry parle volontiers, tutoie vite. Il dit s'ennuyer "à mourir" depuis le licenciement, bricole chez les uns et les autres.
En parlant de l'ambiance des chantiers, il dit que "l'alcool, c'était rien à côté de ce qu'on faisait à l'époque". Il raconte que de 2005 à 2008 environ, il prenait de la cocaïne presque tous les samedis soir avec deux collègues ("un gramme à trois, pour tenir la fête"), et qu'il a arrêté après une grosse dispute avec Sylvie, "quand la petite est née, ou juste après". Jamais injecté, jamais reparlé depuis, "à l'entrée j'ai dit que je n'avais jamais touché à rien, je ne voulais pas qu'on me prenne pour un drogué".
Pas de consommation actuelle de cocaïne ni d'autre produit, alcool "zéro depuis un an".
Pistes pro : reconversion dans le bâtiment "mais assis" (métreur, dessinateur, conducteur de travaux ?). Rencontre Cap emploi à prévoir.
Occupation : propose de venir à l'atelier bricolage du jeudi au CSAPA, "pour réparer vos chaises". Il cherche aussi à reprendre le club de foot, sans la buvette cette fois.

HISTORIQUE DES OBSERVATIONS

Transmis au Dr LOUSTAUNAU.

Observation psychiatrique de suivi du 05/04/2022 (Urgence : Bas)

Validé par LOUSTAUNAU Agnès - Psychiatre addictologue le 05/04/2022 à 12:25
Observations :
Vu ce jour
Un an d'abstinence fêté avec le groupe de prévention de la rechute. Fier, "un an, je ne l'avais jamais fait".
Rappel : TUAL sévère, 1er sevrage hospitalier 2011, puis 2016, 06/2019, 04/2021 (crise convulsive de sevrage le dimanche précédent), SSR 2021. Cocaïne festive 2005-2008 (confiée à M. BENSALAH). TS 2009. EDC 2009, 2016, 2020. Fibrose F3.
Demande à diminuer l'escitalopram ("je me sens bien, je ne veux pas de cachets toute ma vie").
Bromazépam : "un le soir, pas tous les jours".
Conclusions :
- Escitalopram diminué à 10 mg pendant 1 mois puis réévaluation
- RO acamprosate 2-2-2
- RDV 2 mois

Observation psychiatrique de suivi du 21/06/2022 (Urgence : Bas)

Validé par LOUSTAUNAU Agnès - Psychiatre addictologue le 21/06/2022 à 11:35
Observations :
Vu ce jour
A arrêté l'escitalopram de lui-même début mai, après 3 semaines à 10 mg. Pas de rechute dépressive à ce jour, un peu plus irritable.
Abstinent. Acamprosate pris "matin et soir, j'oublie le midi".
Son père est hospitalisé régulièrement (cirrhose décompensée), le patient s'en occupe avec sa mère.
Fibroscan de mai stable.
Conclusions :
- Surveillance thymique, reprise de l'antidépresseur si besoin
- RO acamprosate
- RDV septembre

Observation IDE du 06/09/2022 (Urgence : Bas)

Validé par GARROS Fabienne - IDE le 06/09/2022 à 15:10
M. BROUSTAUT vient avec un peu de retard, gêné. Il annonce qu'il a "repris" : au mariage de son cousin le 13 août, "une coupe pour trinquer", puis la soirée entière. Depuis, il boit le week-end, "6 à 8 bières le samedi et le dimanche", pas en semaine selon lui. Pas de tremblements. Éthylotest 0,00 (mardi).
A arrêté l'acamprosate "à la mi-août, ça servait plus à rien".
Son père est de nouveau hospitalisé, "il en a plus pour longtemps".
Encouragé à en parler au Dr LOUSTAUNAU, RDV le 20/09 maintenu.

Observation psychiatrique de suivi du 20/09/2022 (Urgence : Bas)

Validé par LOUSTAUNAU Agnès - Psychiatre addictologue le 20/09/2022 à 12:00
Observations :
Vu ce jour
Rechute depuis le 13/08/2022 après 16 mois d'abstinence : consommations le week-end, 6 à 8 UIA/j ces jours-là, parfois le vendredi. Pas de consommation matinale, pas de signe de sevrage.
Contexte : fin de vie de son père (cirrhose), ennui, absence de projet.
Refuse de reprendre un objectif d'abstinence immédiat : "je veux juste ne pas replonger comme avant".
Thymie : un peu triste, sommeil correct, pas d'idées suicidaires.
Conclusions :
- Objectif de réduction, nalméfène 18 mg à prendre 1 à 2 heures avant les situations à risque
- Acamprosate non repris

- Bilan bio
- RDV 6 semaines, IDE tous les 15 jours

Entretien téléphonique du 22/11/2022 (Urgence : Bas)

Validé par GARROS Fabienne - IDE le 22/11/2022 à 10:25
Appel du patient, voix pâteuse à 10h. Son père est décédé samedi 12 novembre à l'hôpital, obsèques jeudi dernier. Dit boire "tous les jours depuis", sans pouvoir chiffrer ("beaucoup"). Pleure. Nie toute idée suicidaire quand je lui pose la question, "faut que je m'occupe de ma mère".
Nalméfène : "j'en prends plus".
Vu avec le Dr LOUSTAUNAU : RDV avancé au 29/11, je le rappelle jeudi.

Observation psychiatrique de suivi du 29/11/2022 (Urgence : Bas)

Validé par LOUSTAUNAU Agnès - Psychiatre addictologue le 29/11/2022 à 13:40
Observations :
Vu ce jour
Décès de son père le 12/11/2022. Depuis : consommation quotidienne, environ 12 UIA/j, consommation matinale reprise, tremblements au réveil.
Thymie : tristesse profonde, anhédonie, insomnie, culpabilité ("je n'ai jamais pu lui dire"), ralentissement. Il décrit les derniers jours de son père à l'hôpital, jaune, confus, "il ne me reconnaissait plus", et la peur de "finir pareil, dans le même lit". Il n'a pas pu parler aux obsèques. Il mange peu, a perdu 4 kg en trois semaines, ne sort plus que pour acheter de l'alcool et voir sa mère. Idées de mort ("je pense à le rejoindre") sans scénario, critiquées. EDC sévère, 4e épisode.
Bromazépam : "toujours le soir".
A retrouvé aux obsèques une amie d'enfance, Patricia, qui l'appelle tous les jours.
Conclusions :
- Venlafaxine LP 75 mg/j
- Arrêt du nalméfène (inefficace, non pris)
- Thiamine reprise
- Hospitalisation (sevrage ou psychiatrie) proposée, refusée pour l'instant "pas avant les fêtes, pour ma mère"
- Plan de crise revu, 3114. RDV dans 15 jours, appel IDE hebdomadaire

Observation psychiatrique de suivi du 17/01/2023 (Urgence : Bas)

Validé par LOUSTAUNAU Agnès - Psychiatre addictologue le 17/01/2023 à 15:10
Observations :
Vu ce jour, accompagné de Patricia.
Aggravation depuis les fêtes. Idées suicidaires quotidiennes, avec un scénario : se pendre dans la grange de son père, "là où il bricolait", qu'il est allé voir le week-end dernier. Ambivalence, critique partielle. Consommation 12 à 15 UIA/j.
Insomnie totale certaines nuits.
Rappel : TS par IMV en 2009.
Conclusions :
Crise suicidaire avec scénario, chez un patient alcoolodépendant ayant un antécédent de TS. Hospitalisation en psychiatrie, acceptée en soins libres : admission ce jour au CH (unité de psychiatrie adulte), transport organisé. Sevrage à faire dans le service. Contact avec le psychiatre de l'unité, transmission du dossier.
Patricia l'accompagne jusqu'à l'admission. Le patient demande que sa mère "ne sache pas pourquoi" ; il l'appellera lui-même. Il remet ses clés de la grange à Patricia.
Traitement transmis : venlafaxine LP 75 mg, thiamine, bromazépam selon le MT (1 le soir d'après lui).
RDV au CSAPA à prévoir dès la sortie, l'équipe de psychiatrie nous préviendra.

Observation psychiatrique de suivi du 14/02/2023 (Urgence : Bas)

Validé par LOUSTAUNAU Agnès - Psychiatre addictologue le 14/02/2023 à 11:50
Observations :
Vu ce jour
Sorti le 09/02/2023 après 3 semaines et demie d'hospitalisation en psychiatrie. Sevrage fait dans le service sous

diazépam, sans complication. Venlafaxine augmentée à 150 mg. Plus d'idées suicidaires, critique le scénario ("je ne sais pas ce qui m'a pris, enfin si, je sais").
Abstinent depuis l'entrée. Demande "quelque chose de fort" pour ne pas reboire : disulfirame discuté (hépatopathie F3 : surveillance des transaminases), il accepte. Patricia propose de "surveiller la prise".
Le bromazépam a été arrêté pendant l'hospitalisation, il dit ne pas en avoir repris.
Il raconte le séjour : les premiers jours "dans le brouillard", puis des entretiens quotidiens, l'ergothérapie, les visites de Patricia et de Manon. Il dit avoir compris "qu'on peut être triste sans boire, et boire sans être triste". Il a écrit à son frère pour lui dire ce qu'il avait prévu de faire, "pour ne plus le garder pour moi".
Plan de crise réactualisé avec lui, Patricia a les numéros.
Conclusions :
- Disulfirame 250 mg/j, bilan hépatique à 15 jours puis mensuel
- Venlafaxine LP 150 mg
- Psychologue à reprendre
- RDV 1 mois

Entretien téléphonique du 14/03/2023 (Urgence : Bas)

Validé par GARROS Fabienne - IDE le 14/03/2023 à 09:50
Appel de la pharmacie de Langon (Mme la pharmacienne titulaire) : M. BROUSTAUT présente depuis plusieurs mois des ordonnances de bromazépam de deux médecins différents (Dr PEYRÉ et un médecin de Saint-Macaire), et a acheté "3 boîtes par mois depuis l'été dernier", encore une boîte la semaine dernière malgré la sortie d'hôpital. Elle préfère nous prévenir.
Rappel du patient : il reconnaît assez vite. "Depuis l'été, j'en prenais 4, 5, parfois 6 par jour, ça remplaçait l'alcool, et après ça allait avec". Il continue "à 3 ou 4 par jour" depuis la sortie.
Vu avec le Dr LOUSTAUNAU : RDV le 21/03, pas de modification d'ici là, ne pas arrêter brutalement (risque de crise). Accord pour qu'on appelle le Dr PEYRÉ.

Observation psychiatrique de suivi du 21/03/2023 (Urgence : Bas)

Validé par LOUSTAUNAU Agnès - Psychiatre addictologue le 21/03/2023 à 12:30
Observations :
Vu ce jour
Mésusage de bromazépam depuis l'été 2022 (jusqu'à 6 cp de 6 mg/j, deux prescripteurs), révélé par la pharmacie le 14/03. Prise actuelle 3 à 4 cp/j. Honteux, soulagé "que ça se sache".
Abstinent d'alcool depuis le 17/01 selon lui. Disulfirame pris chaque matin, transaminases stables.
Thymie améliorée sous venlafaxine 150 mg.
Échange avec le Dr PEYRÉ : prescripteur unique désormais au CSAPA, l'autre médecin prévenu.
Conclusions :
- Arrêt du bromazépam, relais par diazépam 10 mg x 3/j, puis diminution de 5 mg toutes les 2 semaines
- Délivrance hebdomadaire en pharmacie
- RO disulfirame 250 mg, venlafaxine 150 mg
- RDV 1 mois, IDE tous les 15 jours

Observation IDE du 06/06/2023 (Urgence : Bas)

Validé par GARROS Fabienne - IDE le 06/06/2023 à 14:45
Entretien IDE de suivi. Diazépam à 15 mg/j (5-5-5) depuis début mai, conforme au plan, délivrance hebdo respectée selon la pharmacie. Dit que le disulfirame est "pris tous les matins devant Patricia". Éthylotest 0,00.
Fume 25 cig/j, "j'ai pris 6 kilos". Rien de nouveau par ailleurs. Prochain bilan hépatique fin juin.

Observation psychiatrique de suivi du 19/09/2023 (Urgence : Bas)

Validé par LOUSTAUNAU Agnès - Psychiatre addictologue le 19/09/2023 à 10:45
Observations :
Vu ce jour
S'est installé chez Patricia à Saint-Macaire début septembre (a rendu son appartement de Langon). "Une vie normale,

enfin".
Se dit abstinent depuis février, disulfirame "tous les jours". Diazépam 5 mg le soir.
Thymie bonne, venlafaxine 150 mg. Pas d'idées suicidaires. Manon (17 ans) vient le week-end, s'entend bien avec Patricia.
Mme ESQUERRÉ : il n'est pas revenu depuis l'hospitalisation, "plus besoin" dit-il.
Conclusions :
- Diazépam 5 mg : arrêt à programmer d'ici la fin de l'année
- RO disulfirame, venlafaxine 150 mg
- Bilan bio complet (GGT, CDT, transaminases) dans le mois
- RDV 2 mois

Observation IDE du 07/11/2023 (Urgence : Bas)

Validé par GARROS Fabienne - IDE le 07/11/2023 à 16:30
Résultats du bilan du 31/10 : GGT 236 (58 en juin), CDT 3,6 %, VGM 100, ASAT/ALAT 74/52. Très discordant avec l'abstinence déclarée.
M. BROUSTAUT nie toute consommation : "c'est peut-être les médicaments". Agacé, écourte l'entretien.
Transmis au Dr LOUSTAUNAU. Éthylotest 0,00 à 16h.

Entretien téléphonique du 21/11/2023 (Urgence : Bas)

Validé par LOUSTAUNAU Agnès - Psychiatre addictologue le 21/11/2023 à 18:05
Observations :
Appel de Mme Patricia LAVIGNASSE, compagne du patient, qui a trouvé le numéro sur une ordonnance. Elle dit appeler "avec son accord, enfin, il sait que j'appelle".
Elle a découvert des cadavres de bouteilles de bière dans le garage et dans la camionnette. En discutant, il a fini par lui avouer qu'il ne prenait plus le disulfirame "depuis Pâques" (il le faisait semblant devant elle puis le recrachait) et qu'il boit "6 à 8 bières par jour en cachette" depuis le printemps, le plus souvent l'après-midi quand elle est au travail.
Elle est inquiète pour le foie et pour lui, ne veut pas le quitter "mais pas comme ça".
Pas d'élément d'urgence vitale décrit, pas de propos suicidaires.
Conclusions :
RDV avancé au 28/11 avec le patient, Patricia peut l'accompagner s'il le souhaite. Je ne lui transmets aucune information médicale.

Observation psychiatrique de suivi du 28/11/2023 (Urgence : Bas)

Validé par LOUSTAUNAU Agnès - Psychiatre addictologue le 28/11/2023 à 12:20
Observations :
Vu ce jour avec Patricia (à sa demande).
Confirme : arrêt du disulfirame vers Pâques 2023 ("je l'ai recraché pendant des mois"), reprise de l'alcool à peu près au même moment, 6 à 8 bières/j cachées, sans consommation matinale jusqu'à ces dernières semaines (tremblements au réveil depuis 15 jours). L'"abstinence depuis février" déclarée en septembre était donc fausse. GGT/CDT d'octobre concordants.
Diazépam : toujours 5 mg le soir, pas de mésusage selon la pharmacie.
Thymie stable, pas d'idées suicidaires. Soulagé, honteux.
Patricia dit qu'elle reste "à condition que tout soit sur la table". Il raconte qu'il achetait les bières dans un autre village "pour ne pas croiser de connaissance", et qu'il se brossait les dents avant son retour.
Ne veut pas être hospitalisé ; entourage présent, pas d'antécédent de convulsion sous sevrage encadré, la crise de 2021 était un arrêt brutal sans traitement.
Conclusions :
- Sevrage ambulatoire à partir du 04/12 : diazépam 10 mg x 3/j pendant 3 jours puis décroissance sur 7 jours jusqu'à l'arrêt complet du diazépam ; thiamine 500 mg/j ; passage IDE quotidien les 4 premiers jours
- Disulfirame arrêté définitivement
- Naltrexone 50 mg/j dès la fin du sevrage
- Venlafaxine 150 mg poursuivie

HISTORIQUE DES OBSERVATIONS

Observation IDE du 09/01/2024 (Urgence : Bas)

Validé par GARROS Fabienne - IDE le 09/01/2024 à 15:00
Sevrage ambulatoire fait du 04/12 au 13/12 sans incident (passages IDE à domicile les 4 premiers jours). Diazépam arrêté le 13/12 : plus aucune benzodiazépine depuis, "et je ne vais pas en redemander".
Naltrexone 50 mg depuis le 14/12, un peu de nausées la première semaine. Abstinent depuis le 04/12 selon lui et selon Patricia (présente). Éthylotest 0,00.
Veut arrêter de fumer "tant que je suis lancé" : vu avec le Dr LOUSTAUNAU, consultation tabac le 15/01.

Observation psychiatrique de suivi du 13/02/2024 (Urgence : Bas)

Validé par LOUSTAUNAU Agnès - Psychiatre addictologue le 13/02/2024 à 11:10
Observations :
Vu ce jour
Varénicline débutée le 15/01 (titration standard, 1 mg x 2 à J8), dernière cigarette le 29/01. "Deux semaines sans fumer, après 38 ans". Nausées modérées, rêves intenses.
Abstinent d'alcool depuis début décembre. Naltrexone 50 mg. GGT 88.
Thymie stable, venlafaxine 150 mg.
Conclusions :
- Varénicline 1 mg x 2 pour 12 semaines
- RO naltrexone 50 mg, venlafaxine 150 mg
- RDV 3 mois

Renouvellement du 02/04/2024 (Urgence : Bas)

Validé par GARROS Fabienne - IDE le 02/04/2024 à 09:40
Passage pour renouvellement naltrexone (ordonnance 3 mois préparée par le Dr LOUSTAUNAU). Patient pressé, rendez-vous à la préfecture pour son permis. Pas d'entretien.

Synthèse annuelle du 14/05/2024 (Urgence : Bas)

Validé par LOUSTAUNAU Agnès - Psychiatre addictologue le 14/05/2024 à 16:45
Observations :
Synthèse du suivi, 5 ans après le premier contact (mai 2019).
M. BROUSTAUT Thierry, 51 ans, ancien chef d'équipe maçon, licencié pour inaptitude en 2021, vit avec sa compagne à Saint-Macaire.
Alcool : premières consommations vers 16 ans, usage quotidien depuis le service militaire, perte de contrôle vers 30 ans.
Sevrages avant le suivi : hospitalier en 2011 (Lormont, retrouvé en 2021), ambulatoire en 2014, hospitalier en 2016.
Pendant le suivi : obligation de soins (2019) après annulation du permis ; sevrage hospitalier en juin 2019, 6 mois d'abstinence, rechute à Noël 2019 et séparation ; baclofène 2020-2021 ; essai de consommation contrôlée (septembre 2020 à janvier 2021), échec ; crise convulsive de sevrage en mars 2021 ; sevrage hospitalier en avril 2021 puis SSR à Cadillac ; 16 mois d'abstinence ; rechute en août 2022 puis aggravation au décès du père (novembre 2022) ; sevrage lors de l'hospitalisation en psychiatrie (janvier-février 2023) ; disulfirame, arrêté en cachette à Pâques 2023, consommation cachée jusqu'en novembre ; sevrage ambulatoire en décembre 2023 ; abstinent depuis, sous naltrexone.
Autres produits : tabac depuis 13 ans, arrêt fin janvier 2024 sous varénicline, reprise il y a 3 semaines à 10 cig/j ("une cigarette avec un voisin, puis le paquet") ; varénicline arrêtée par lui. Cocaïne festive 2005-2008. Mésusage de bromazépam (été 2022 - mars 2023), sevré en décembre 2023.
Psychiatrie : trouble dépressif récurrent (EDC 2009 avec TS par IMV, 2016, 2020, 2022-2023 avec hospitalisation de janvier à février 2023). Violences paternelles dans l'enfance. Venlafaxine 150 mg, thymie stable depuis l'été 2023.
Somatique : hépatopathie alcoolique, fibrose F3 (2020), suivi hépatologique ; séquelles de fracture du calcanéum G (AT 2019).
Social : divorcé (2021), deux enfants (Kevin 23 ans, Manon 18 ans), plan de surendettement en cours, RQTH, commission médicale du permis favorable en mars.
Conclusions :
TUAL sévère en rémission précoce (5 mois). Trouble dépressif récurrent, en rémission. Trouble de l'usage du tabac, rechute.

- RO naltrexone 50 mg, venlafaxine 150 mg
- Proposition de substituts nicotiniques, à revoir
- Projet professionnel avec M. BENSALAH
- RDV 3 mois

Observation sociale du 25/06/2024 (Urgence : Bas)

Validé par DUVIGNAC Sandrine - Assistante sociale le 25/06/2024 à 11:20
Point de situation.
Permis de conduire : commission médicale favorable en mars (permis valable 1 an, renouvellement soumis à avis médical), examens repassés, permis récupéré le 12/06/2024. "Je ne prendrai plus jamais le volant avec un verre". Rappel : annulation en mars 2019 après le contrôle de fin 2018.
Plan de surendettement en cours (mensualité 180 €, fin prévue en 2027), aucun nouvel impayé.
Domicile : 18 chemin du Pradas, 33490 SAINT-MACAIRE, chez sa compagne Mme LAVIGNASSE.
Ressources : fin des droits ARE en septembre, ASS demandée. RQTH valable jusqu'en 2026.
Projet de formation de reconversion (métreur) en cours avec M. BENSALAH et Cap emploi.

RDV non honoré du 08/10/2024 (Urgence : Bas)

Validé par GARROS Fabienne - IDE le 08/10/2024 à 15:30
Patient absent au RDV IDE de 14h30. SMS de sa part à 15h20 : "désolé, chez Kevin, la petite arrive en janvier, on refait la chambre". RDV redonné en novembre.

Observation psychiatrique de suivi du 10/12/2024 (Urgence : Bas)

Validé par LOUSTAUNAU Agnès - Psychiatre addictologue le 10/12/2024 à 12:05
Observations :
Vu ce jour
Un an d'abstinence (depuis le 04/12/2023). GGT 41, CDT normale. Fibroscan de novembre : 9,1 kPa, amélioration nette (13,2 en 2020).
Tabac 10 cig/j. Naltrexone 50 mg bien tolérée.
Thymie stable depuis plus d'un an, demande à diminuer l'antidépresseur.
Va devenir grand-père en janvier, "ça me fait drôle, j'ai envie d'être là pour elle".
Conclusions :
- Venlafaxine LP diminuée à 75 mg/j
- RO naltrexone 50 mg
- RDV 3 mois

Observation éducative du 04/03/2025 (Urgence : Bas)

Validé par BENSALAH Karim - Éducateur spécialisé le 04/03/2025 à 16:40
Thierry passe annoncer que son dossier de formation est accepté : titre professionnel de métreur à l'AFPA de Bordeaux, rentrée le 08/09/2025, financement validé par France Travail et l'Agefiph. Il a réussi les tests de positionnement ("des maths, à mon âge !").
Grand-père depuis le 21/01 (Lina, fille de Kevin), montre les photos sur son téléphone.
Organisation : trajets en train Langon-Bordeaux, Patricia l'aidera pour l'informatique.
Il dit qu'il a arrêté la naltrexone "en février, je n'en ai plus besoin", sans en avoir parlé au médecin. Je l'encourage à en parler au Dr LOUSTAUNAU.

Entretien téléphonique du 08/04/2025 (Urgence : Bas)

Validé par GARROS Fabienne - IDE le 08/04/2025 à 10:10
Appel de M. BROUSTAUT. A rebu "depuis mon anniversaire", le 14/03 : fête de ses 52 ans chez son frère, "un verre de vin", puis tous les jours depuis, 8 à 10 bières/j. Tremblements le matin depuis une semaine, s'inquiète d'une crise "comme en 2021". Patricia est au courant, c'est elle qui lui a dit d'appeler.
Pas de naltrexone depuis février.
Vu avec le Dr LOUSTAUNAU : consultation le 10/04, ne pas arrêter seul d'ici là.

HISTORIQUE DES OBSERVATIONS

Observation psychiatrique de suivi du 10/04/2025 (Urgence : Bas)

Validé par LOUSTAUNAU Agnès - Psychiatre addictologue le 10/04/2025 à 11:30

Observations :
Vu ce jour avec Patricia
Rechute depuis le 14/03/2025 après 15 mois d'abstinence : 8 à 10 UIA/j, tremblements matinaux. Naltrexone arrêtée par lui en février.
Pas d'idées suicidaires, thymie "pas terrible, la honte surtout". Venlafaxine 75 mg poursuivie.
Rappel : TUAL sévère, crise convulsive de sevrage en mars 2021 lors d'un arrêt brutal non encadré.
Conclusions :
- Sevrage ambulatoire à partir de demain 11/04 : diazépam 10 mg x 4/j J1-J2, puis décroissance sur 8 jours ; thiamine ; passages IDE quotidiens les 3 premiers jours, Patricia présente
- Reprise naltrexone 50 mg à la fin du sevrage
- Reprise des entretiens avec Mme ESQUERRÉ
- RDV dans 1 mois

Observation IDE du 22/04/2025 (Urgence : Bas)

Validé par GARROS Fabienne - IDE le 22/04/2025 à 14:20

Fin du sevrage ambulatoire : diazépam arrêté le 19/04 comme prévu, pas de complication, pas de crise. Abstinent depuis le 11/04. Éthylotest 0,00.
Naltrexone reprise ce jour (ordonnance du Dr LOUSTAUNAU).
Dit avoir "eu peur pour la formation" ; motivé.

Observation psychologue du 17/06/2025 (Urgence : Bas)

Validé par ESQUERRÉ Nathalie - Psychologue le 17/06/2025 à 18:30

Reprise du suivi après deux ans d'interruption.
M. Broustaut revient sur la rechute de mars : "à mon anniversaire, j'ai pensé à mon père, il fêtait toujours le mien en buvant". Il relie les rechutes aux dates, aux fêtes, aux deuils.
Il parle de Lina, sa petite-fille, avec beaucoup de douceur, et de la peur de "lui transmettre ça". Il évoque sans détour la nuit de 2009 ("il y a seize ans, je ne pensais pas être encore là"), ce qu'il n'aurait pas pu faire il y a quelques années.
Il revient aussi sur les violences de l'enfance, avec moins de honte : "c'était lui le problème, pas moi". Il dit avoir parlé à son frère Didier, qui "se souvenait de tout".
Travail proposé : repérage des dates anniversaires, lettre au père (non envoyée). Rythme mensuel.

Observation psychiatrique de suivi du 16/09/2025 (Urgence : Bas)

Validé par LOUSTAUNAU Agnès - Psychiatre addictologue le 16/09/2025 à 12:15

Observations :
Vu ce jour
Formation de métreur à l'AFPA de Bordeaux commencée le 08/09/2025 (10 mois, stage en entreprise au printemps).
Fatigué par les trajets mais "content d'apprendre".
Abstinent depuis le 11/04. Naltrexone 50 mg, venlafaxine 75 mg. Tabac 10 cig/j.
Conclusions :
- RO naltrexone, venlafaxine 75 mg
- RDV en novembre avec l'interne (horaires adaptés à la formation)

Observation psychiatrique de suivi du 18/11/2025 (Urgence : Bas)

Validé par TAUZIN Léa - Interne le 18/11/2025 à 18:20

Observations :
Patient vu ce jour (première rencontre).
Rappel des antécédents : TUAL sévère, début vers 14 ans. 1er sevrage hospitalier en 2016, sevrages en 2019 et 2021 (crise convulsive), SSR 2021, sevrages ambulatoires 2023 et 2025. Trouble dépressif récurrent, TS 2009, hospitalisation psy 2023. Hépatopathie F3. Mésusage de BZD 2022-2023.
Actuellement : abstinent depuis avril 2025 (7 mois). Formation AFPA en cours, résultats bons. Vie de couple stable.

Thymie euthymique, sommeil bon.
Naltrexone 50 mg, venlafaxine 75 mg. Tabac 10 cig/j.
Conclusions :
- RO
- Questionne l'arrêt de la naltrexone : à discuter en mars avec le Dr LOUSTAUNAU
- RDV mars

Appel pharmacie du 13/01/2026 (Urgence : Bas)

Validé par GARROS Fabienne - IDE le 13/01/2026 à 11:00
Appel de la pharmacie de Saint-Macaire : ordonnance de venlafaxine périmée depuis le 10/01. Ordonnance de 3 mois refaite par le Dr LOUSTAUNAU, envoyée par messagerie sécurisée. RAS.

Observation psychiatrique de suivi du 10/03/2026 (Urgence : Bas)

Validé par TAUZIN Léa - Interne le 10/03/2026 à 17:50
Observations :
Patient vu ce jour avec le Dr LOUSTAUNAU.
Abstinent depuis le 11/04/2025 (11 mois). A passé son anniversaire "en famille, avec du jus de pomme", en ayant préparé la date avec la psychologue. GGT 32.
En stage dans un cabinet d'économistes de la construction à Langon jusqu'en mai.
Demande l'arrêt de la naltrexone, décision partagée.
Conclusions :
- Arrêt de la naltrexone ce jour
- Venlafaxine 75 mg poursuivie
- Plan de prévention de la rechute écrit (dates anniversaires, signaux d'alerte, qui appeler)
- RDV juin

Observation psychiatrique de suivi du 16/06/2026 (Urgence : Bas)

Validé par LOUSTAUNAU Agnès - Psychiatre addictologue le 16/06/2026 à 11:25
Observations :
Vu ce jour
Titre professionnel de métreur obtenu le 05/06/2026. Proposition d'embauche du cabinet de son stage en CDD à partir de septembre.
Abstinent depuis plus d'un an, sans naltrexone depuis mars. Fibroscan du 02/06 : 7,8 kPa.
Thymie bonne. Tabac 10 cig/j, "le prochain chantier".
Conclusions :
- Venlafaxine 75 mg, diminution à discuter à l'automne
- RDV octobre

Observation psychiatrique de suivi du 06/10/2026 (Urgence : Bas)

Validé par LOUSTAUNAU Agnès - Psychiatre addictologue le 06/10/2026 à 10:40
Observations :
Vu ce jour
En CDD de métreur depuis le 01/09/2026 (6 mois renouvelable), "assis, mais toujours dans le bâtiment". Fatigue, satisfaction.
Abstinent depuis le 11/04/2025 (18 mois). Aucun traitement anticraving. Pas de benzodiazépine.
Thymie stable depuis 3 ans, venlafaxine 75 mg : il souhaite attendre la fin de l'hiver pour arrêter.
Manon (20 ans) en BTS à Bordeaux, vient manger le dimanche. Lina a 20 mois.
Tabac 10 cig/j, demande des substituts nicotiniques pour le prochain mois sans tabac.
Conclusions :
- RO venlafaxine LP 75 mg
- Patchs nicotiniques 14 mg/24h + formes orales
- Consultations espacées tous les 3 mois, IDE à la demande

CENTRE HOSPITALIER FICTIF DES COTEAUX
Pôle d'addictologie - CSAPA - 3, allée des Fictifs - 33210 LANGON
Tél. 05 00 21 43 65 Finess 33 0 99981 2

BROUSTAUT THIERRY Admission A1905140017
Né le 14/03/1973 (53 ans)
IPP 0093318472 UF 5130 - Addictologie
18 chemin du Pradas, 33490 SAINT-MACAIRE

HISTORIQUE DES OBSERVATIONS

- RDV janvier 2027